

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE JUEGO DE SOUTH OAKS (SOGS)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación de Juego Problemático y Trastorno por Juego de Azar (Ludopatía)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Detección de Juego de South Oaks (SOGS).
Nombre Original (Inglés)	<i>South Oaks Gambling Screen (SOGS)</i>
Autores Originales	Henry R. Lesieur y Sheila B. Blume (1987), South Oaks Hospital, Nueva York.
Adaptaciones Españolas	Echeburúa, Báez, Fernández-Montalvo y Páez (1994, validación de referencia); Becoña (1996); DGOJ (Ministerio de Consumo).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Cribado epidemiológico y clínico de adicciones comportamentales.
Tipo de Instrumento	Autoinforme/heteroinforme compuesto por preguntas de modalidad de juego e ítems puntuables (0 a 20 puntos).
Población y Rango	Adultos y jóvenes (≥ 16 años). Consultas de adicciones, salud mental, atención primaria y medicina legal.
Tiempo de Administración	6 a 10 minutos.
Régimen de Licencia	Dominio público para fines asistenciales, sanitarios y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DEL JUEGO PATOLÓGICO

El SOGS es el estándar de oro internacional diseñado por Lesieur y Blume (1987) para evaluar el **Trastorno por Juego de Azar** (Ludopatía), formalmente clasificado en el DSM-5 dentro de los Trastornos Relacionados con Sustancias y Trastornos Adictivos (adicciones no químicas o comportamentales).

Desde la perspectiva neurobiológica, el juego patológico comparte con las drogodependencias la alteración funcional de las vías meso-corticolímbicas de la dopamina, caracterizada por un sesgo cognitivo de recompensa inmediata y desregulación del control prefrontal. El SOGS operacionaliza los síntomas cardinales del trastorno: la **tolerancia** (necesidad de apostar cantidades crecientes), el **síndrome de abstinencia** (inquietud o irritabilidad al intentar reducir el juego), el fenómeno del **chasing** (perseguir las pérdidas volviendo a jugar para recuperarlas) y la **desestructuración financiera y relacional**.

3. DIMENSIONES EVALUADAS EN EL SOGS (LESIEUR & BLUME, 1987; ECHEBURÚA ET AL., 1994)

Dimensión Clínica	Reactivos	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
1. Persecución de Pérdidas	Ítems 4 y 5	0 a 2	El fenómeno de “caza”: regresar al día siguiente para recuperar lo perdido y engañar sobre las ganancias.
2. Pérdida de Control	Ítems 6, 7, 8, 10	0 a 4	Reconocer que se tiene un problema, jugar más de lo planeado, culpa y sentirse incapaz de parar.
3. Ocultación y Conflicto	Ítems 9, 11, 12, 16	0 a 4	Críticas de allegados, esconder recibos/dinero, discusiones graves y faltar al trabajo o clases.
4. Endeudamiento y Financiación	Ítems 13, 14, 15	0 a 10	Obtención de fondos ilegítimos: préstamos usurarios, tarjetas al límite, venta de joyas y prestamistas.
PUNTUACIÓN TOTAL SOGS	Puntuables	0 a 20	Índice acumulativo estandarizado de severidad del juego patológico.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente homogeneidad: coeficiente alfa de Cronbach de 0.94 en la validación clínica española de Echeburúa et al. (1994) en jugadores patológicos en tratamiento.
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte estándar <i>ge5</i> : sensibilidad del 94% y especificidad del 96% frente al diagnóstico clínico formal DSM-IV y DSM-5 de Trastorno por Juego.
Validez Concurrente	Correlación elevada con el Cuestionario de Juego de Heidelberg ($r = 0.81$), la Escala de Impulsividad de Barratt (BIS-11 $r = 0.58$) y el NODS ($r = 0.88$).
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.88$ a las cuatro semanas en muestras clínicas ambulatorias.
Poder Discriminante	Distingue de forma contundente entre jugadores sociales (0 a 1 punto), jugadores problema con riesgo incipiente (1 a 4 puntos) y ludópatas clínicos (<i>ge5</i> puntos).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Las preguntas de catálogo de modalidades de juego (tragaperras, ruleta, apuestas online) no se puntúan directamente, sirviendo como mapa del hábito. Los reactivos puntuables suman **1 punto** por cada indicador patológico afirmativo:

- **Cálculo de la Puntuación Total:** Suma de las respuestas que reflejan descontrol, mentiras, deudas y mecanismos de financiación desesperada.

Puntuación Total SOGS: 0 a 20 puntos | Punto de Corte Clínico *ge5* puntos

- En la versión institucional abreviada de cribado de la DGOJ (13 cuestiones dicotómicas), se aplica el mismo criterio de *ge5* respuestas afirmativas como umbral de alarma.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (ECHEBURÚA ET AL., 1994; LESIEUR, 1987)

Estrato	Puntuación	Estado Conductual	Conducta Asistencial Recomendada
Sin Problema	0	Jugador social / No jugador	Gasto y tiempo en juego ajustados al ocio normativo. No requiere intervención.
Juego Problema	1 a 4	Jugador en riesgo / Problema leve	Pérdidas esporádicas de control. Psicoeducación y prevención de escalada conductual.
Ludopatía	5 a 9	Probable Jugador Patológico (Corte)	Cuadro sindrómico de Juego Patológico (DSM-5). Terapia cognitivo-conductual e interdicción.
Ludopatía Grave	10 a 20	Juego Patológico Severo / Colapso	Ruptura psicosocial total, deudas masivas y riesgo delictivo. Tratamiento integral en unidad de adicciones.

EL RIESGO DEL JUEGO ONLINE Y APUESTAS DEPORTIVAS: En adolescentes y jóvenes adultos, el juego online y las apuestas deportivas a través del smartphone presentan una tasa de aceleración hacia la ludopatía mucho más rápida que el juego presencial tradicional, alcanzando puntuaciones severas en el SOGS en menos de 12 meses desde el inicio del hábito.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y CONTROL DE ESTÍMULOS

PAUTA TERAPÉUTICA ANTE UN SOGS ^{ge5}:

- **Paso 1 (Medidas Inmediatas de Contención):** Tramitar la autoexclusión en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) y ceder temporalmente el control financiero (cuentas bancarias, tarjetas, nómina) a un familiar de confianza.
- **Paso 2 (Terapia Cognitivo-Conductual):** Desmontar las distorsiones cognitivas nucleares (ilusión de control, falacia del jugador, memoria selectiva de ganancias) y entrenar en prevención de recaídas.
- **Paso 3 (Tratamiento Farmacológico Coadyuvante):** Si existe impulsividad extrema o comorbilidad afectiva, valorar antagonistas opioides (naltrexona a dosis de 50 mg/día para reducir el craving) o ISRS a dosis plenas.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: ADICCIÓN A APUESTAS ONLINE EN JÓVEN

Paciente: Varón de 23 años, empleado en hostelería, traído por sus padres tras descubrirse que había contraído microcréditos de financiación rápida por valor de 18.000 € para apostar en partidos de fútbol internacionales a través de aplicaciones móviles.

Resultados SOGS:

- **Puntuación Total: 14/20 (Ludopatía Severa — Rango Crítico).**
- **Desglose cualitativo:** Afirma haber vuelto al día siguiente para recuperar pérdidas (ítem 4), engañar sobre sus pérdidas (ítem 5), mentir a la familia (ítem 11), vender pertenencias (ítem 14) y recurrir a micropréstamos con usura (ítem 15) para seguir apostando.

Conducta Asistencial: Se diagnostica Trastorno por Juego de Azar Grave (DSM-5). Se inscribe formalmente en el registro de autoexclusión de la DGOJ y se bloquean accesos digitales de pago en su teléfono. Se inicia psicoterapia individual y de grupo en una Unidad de Conductas Adictivas combinada con terapia familiar para la reestructuración de la deuda. A los 6 meses de seguimiento, el paciente mantiene abstinencia absoluta del juego y estabilidad laboral.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DERIVACIÓN URGENTE

ALERTA: RIESGO MÁXIMO DE SUICIDIO

El momento de descubrimiento de deudas impagables por la familia o el acoso de prestamistas es el punto de mayor riesgo de suicidio consumado; realizar cribado autolítico urgente en SOGS ^{ge10}.

DELITOS DE FINANCIACIÓN

Apropiaciones indebidas en la empresa o hurtos en el entorno doméstico son frecuentes en fases avanzadas; clarificar las consecuencias jurídicas y legales con asesoramiento forense.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Lesieur, H. R., & Blume, S. B. (1987). The South Oaks Gambling Screen (SOGS): a new instrument for the identification of pathological gamblers. *The American Journal of Psychiatry*, 144(9), 1184–1188.
2. Echeburúa, E., Báez, C., Fernández-Montalvo, J., & Páez, D. (1994). Cuestionario de Juego de South Oaks (SOGS): validación española de la versión para adultos. *Análisis y Modificación de Conducta*, 20(74), 769–791.
3. Becoña, E. (1996). La ludopatía: prevalencia en España y su evaluación con el SOGS. *Revista Española de Drogodependencias*, 21(2), 115–134.
4. Stinchfield, R. (2002). Reliability, validity, and classification accuracy of the South Oaks Gambling Screen (SOGS). *Addictive Behaviors*, 27(1), 1–19.